# 당뇨 환자를 위한 식이요법 가이드

당뇨 식이요법(의학적 영양 치료) — 식사 구성을 바꾸면 당화혈색소(HbA1c)를 평균 1~2% 낮출 수 있습니다. 한국인 식사 기준 핵심 수치와 접시법, 식품 선택 가이드를 정리했습니다.

## 한눈에 보는 혈당 목표 (Glycemic Targets)

| 당화혈색소 (HBA1C) | 공복혈당 (FPG) | 식후 2시간 혈당 | 탄수화물 1회분 |
|---|---|---|---|
| **<6.5** | **80~130** | **<180** | **45~60** |
| % (대부분 · 고령·저혈당 위험이면 더 높게) | mg/dL (식전) | mg/dL (PPG) | g / 끼 (밥 ⅔공기 수준) |

## 당뇨 접시법 (Diabetes Plate Method · ADA)



½ 채소 · ¼ 단백질 · ¼ 잡곡밥

- **½ 접시 · 채소** — 잎채소·브로콜리·오이·가지·버섯 등 **비전분 채소**로 절반을 채웁니다. 식이섬유가 혈당 상승을 완만하게 합니다.
- **¼ 접시 · 단백질** — 생선·닭가슴살·두부·계란·콩류 등 **저지방 단백질**로 ¼을 채웁니다. 가공육·튀김은 피합니다.
- **¼ 접시 · 탄수화물** — 현미·잡곡밥·고구마·통곡빵 등 **복합 탄수화물**로 ¼만 채웁니다. 흰쌀·흰빵은 줄입니다.

먹는 순서도 중요 — **채소 → 단백질 → 탄수화물** 순서로 먹으면 식후 혈당 피크가 더 낮습니다.

## 식품 선택 가이드 (Do & Don't)

| 권장 식품 · DO | 주의 식품 · DON'T |
|---|---|
| **1. 잡곡밥·현미밥** — 흰쌀밥보다 GI 20~30 낮음 | **1. 흰쌀밥·흰빵 과다** — GI 70+, 혈당 급상승 |
| **2. 비전분 채소 매끼 ½접시** — 식이섬유 풍부 | **2. 단 음료 (주스·탄산·꿀물)** — 즉각 혈당 ↑ |
| **3. 생선·두부·콩류 단백질** — 포화지방 적음 | **3. 떡·죽·국수 단독** — 정제 전분, GI 높음 |
| **4. 견과류 1줌 (30g/일)** — 호두·아몬드, 무염 | **4. 야식·심야 간식** — 야간 혈당·체중 증가 |
| **5. 물 하루 1.5~2L** — 음료 대신 물·녹차 | **5. 튀김·가공육** — 인슐린 저항성 ↑ |
| **6. 식초·레몬·계피**로 맛내기 — 혈당 완화 | **6. 시럽·꿀·과당 시럽** — "건강해 보여도" 같음 |
| **7. 천천히 20분 이상** 꼭꼭 씹어 먹기 | **7. 빈속 과일·말린 과일** 과다 — 과당 농축 |

**인슐린·설포닐우레아 복용 중인 분 — 저혈당 대처 · IMPORTANT**

인슐린·설포닐우레아(아마릴·다오닐 등) 복용 중에 식사를 거르거나 탄수화물을 갑자기 크게 줄이면 **저혈당(혈당 70mg/dL 미만) — 식은땀·떨림·어지러움**이 생길 수 있습니다. 정신이 또렷하면 **포도당 15g 또는 일반 주스 약 120mL(½컵)**를 드시고 **15분 뒤 다시 재서** 여전히 70 미만이면 한 번 더 드세요. 이렇게 반복해도 **70 미만이 계속되면 응급실로 가시거나 119**에 연락하세요. **정신이 흐리거나 삼키기 어렵거나 반응이 없으면** 입으로 주지 말고 **119**에 연락하세요. 반복되면 외래로 연락 주시고, 식이 변경 전 약 용량 점검이 필요합니다. (☏ 031-893-4560)

SGLT2 억제제를 복용한다면 탄수화물을 극단적으로 줄이기 전에 처방 의료진과 상의하세요. 구토·탈수 때는 혈당이 높지 않아도 케톤산증을 평가해야 할 수 있습니다.

*아산 28회 연수강좌 — 똑똑한 비만치료 의사되기: GLP-1 기반약제를 중심으로(정창희)*

**광교바른내과 · Gwanggyo Barun Internal Medicine**

경기도 용인시 수지구 광교중앙로 298, 드림타워2 4층 402~404호 · ☏ 031-893-4560

평일 08:30~18:30 · 토요일 08:30~13:30 · 일요일·공휴일 휴진

근거 — 대한당뇨병학회 진료지침 2023 · 식품교환표 활용지침 제4판(2023) · ADA Standards of Care in Diabetes 2026

*본 자료는 일반적 권고이며, 환자별 약 용량·합병증·신기능에 따라 달라질 수 있습니다. 다음 장에 한국 주식의 GI/GL과 1회분 가이드, 과일·술·간식 전략이 이어집니다.*

집에서 다시 보기

QR 대신 입력 → edu.gwanggyobarun.com/handouts/lifestyle/diabetes-diet/

# 한국 주식의 혈당지수(GI)와 1회 분량 가이드

밥·면·빵의 혈당지수(GI)·혈당부하(GL), 과일·감미료·술의 분량을 정리했습니다.

## 한국인 주식의 GI/GL과 1회분 (탄수화물 ~50g 기준)

| 식품 | GI | 1회분 (탄수화물 g) | 혈당부하 (GL) |
|---|---|---|---|
| **흰쌀밥** | **86** | ⅔공기 140g (45g) | **39** |
| **잡곡밥 (현미·보리)** | **55** | ⅔공기 140g (45g) | **25** |
| **흰식빵** | **75** | 2쪽 (50g) | **19** |
| **통곡빵 (whole grain)** | **53** | 2쪽 (50g) | **13** |
| **국수 (우동·칼국수)** | **62** | 1그릇 (60g 면) | **28** |
| **고구마 (찐 것)** | **55** | 중 1개 (150g) | **17** |

### 과일 — 종류보다 '한 번에 얼마나'

과일 **1회분(1교환 · 탄수화물 약 12g)**은 무게로 봅니다 — **사과·배·귤 100g · 수박·딸기 150g · 단감·바나나 80g · 말린 과일 15g · 주스 100mL**. 과일을 종류로 금지하지 않고, 하루 정해진 교환 수 안에서 합산합니다. 평소엔 주스·말린 과일보다 **생과일**을, 밥·빵에 **더하지 말고 바꿔서** 드세요.

**자세한 과일 무게표 → 「당뇨 환자를 위한 과일 1회량 가이드」** edu.gwanggyobarun.com/handouts/lifestyle/diabetes-fruit-guide/

### 설탕 대체 감미료 (SWEETENERS)

**안전 (혈당 영향 없음):** 스테비아·에리스리톨
**안전:** 알룰로스·몽크프루트 (천연 유래)
**주의:** 자일리톨·말티톨 (다량 시 설사)
**피하기:** 꿀·시럽·아가베 — 사실상 설탕
**피하기:** "무가당" 표시여도 과당·말토덱스트린 확인
**커피·차:** 무가당 또는 스테비아 1포
**제로 음료:** 가끔 OK, 매일 권장 X

### 술 (ALCOHOL) — 안전 분량과 주의

**최대:** 남 2잔/일, 여 1잔/일
**1잔:** 소주 50ml·맥주 350ml·와인 150ml
**빈속 음주 금지** — 저혈당 위험 (인슐린·설포닐우레아)
**맥주·막걸리:** 탄수화물 多, 1잔만
**음주 후** 새벽 저혈당 — 자기 전 혈당 확인

### 간식·야식 전략 (SNACKING)

**원칙:** 끼니 거르지 않으면 간식 불필요
**OK (탄수 15g 이내):** 무가당 요거트
**OK:** 견과류 1줌·삶은 계란·치즈 1조각
**야식 금지** — 저녁 후 4시간 공복
식사량·체중이 줄거나 노쇠한 분은 영양·약·몸의 기능을 함께 살핍니다

*아산 28회 연수강좌 — 왜 이 환자는 계속 안 좋아질까? 개원의가 시작하는 노인 통합돌봄(백지연)*

**식후 30분 산책** — 혈당 피크 완화

### 당뇨 하루 식단 예시 (탄수 ~150G/일)

**아침 ~45g:** 잡곡밥 ⅔공기 · 두부조림 · 시금치나물 · 김치 · 사과 ½개(100g)
**점심 ~50g:** 현미밥 ⅔공기 · 닭가슴살 샐러드 · 미역국 · 나물 2종 — 외식 시 면보다 백반
**저녁 ~45g:** 잡곡밥 ⅔공기 · 흰살생선구이 · 브로콜리 · 김치 · 견과 1줌 — 식후 30분 산책

**광교바른내과 · Gwanggyo Barun Internal Medicine**

근거 — 대한당뇨병학회 진료지침 2023 · 식품교환표 활용지침 제4판(2023) · ADA Standards of Care in Diabetes 2026 · 한국영양학회 한국인 영양소 섭취기준

*GI/GL 수치는 일반적 평균치이며 조리법·동반 식품에 따라 차이가 있습니다. 환자별 식이 처방은 담당 의사·영양사와 상담하시기 바랍니다.*